

学校保健

環境労働衛生学 加藤沙耶香

学校保健とは

- 「学校保健安全法」に則って管理される。

学校保健計画の策定

学校環境衛生水準（幼稚園は適用を受けるが保育所は適用外）
教室環境、飲料水、学校の清潔、ネズミ、衛生害虫、水泳
プール、日常の環境衛生

就学時の健康診断

児童生徒の健康診断

出席停止

臨時休業

我が国の学校保健の特徴

- 保健管理活動：健康診断や健康相談
- 保健教育：体育科・保健体育科をはじめとした教科
子どもが自分自身や他者の健康課題を理解する
自己管理 を行うことができるようにすること
- 保健教育＋保健管理＝児童生徒や教職員の健康を保持増進
心身ともに健康な国民の育成

学校保健の内容

- 学校保健安全法に則る
- 地域の医療機関等との連携：救急処置、健康相談又は保健指導
- 健康診断 児童生徒 就学時、学年ごと
職員 毎年
- 出席停止、休校 校長の権限で行う

学校環境衛生

- 学校保健安全法第5条

学校は「環境衛生検査」を「計画的に策定し、実施しなければならない」

定期検査

「教室等の環境」

「飲料水等の水質及び施設・設備」

「学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理」

「水泳プール」

日常における環境衛生

「教室等の空気」

「飲料水等の水質及び施設・設備」

「学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等」 「水泳プールの管理」、

「臨時に行う検査」

学校医の役割

- 保健管理に関する専門的事項について、技術指導に従事する。
- すべての学校に置く

主な職務

1. 学校保健計画の立案への参与（決定ではない）
2. 必要に応じた保健管理に関する専門的事項の指導
3. 健康相談
4. 保健指導
5. 健康診断（定期・臨時・就学時）、職員の健康診断
6. 疾病の予防
7. 感染症・食中毒の予防措置
8. 救急処置
9. 学校環境衛生の維持・改善の指導

健康診断の実施時期

- 就学時健康診断：就学4か月前まで
- 定期健康診断：毎学年6月30日まで
- 臨時健康診断：食中毒などが発生した時など必要時
- 職員健康診断：毎年

健康診断の実施項目①

- 就学前健診及び定期健康診断
(共通)

1. 栄養状態
2. 脊柱・胸郭・四肢の状態
3. 視力・聴力
4. 眼科健診
5. 耳鼻科健診
6. 歯科検診

- 就学前健診
知能検査を含む

- 定期健康診断(毎年)
身長、体重

- 定期健康診断(特定の学年)
 1. 結核 (レントゲン)
 2. 心臓健診 (心電図)
 3. 尿

就学前健診及び定期健康診断

栄養状態

準備：身長、体重、成長曲線、肥満度の把握
方法

視診または触診

皮膚の色沢

皮下脂肪の充実

筋骨の発達

貧血の有無

判定：最終的な評価は、学校医が総合的に判断して行う

就学前健診及び定期健康診断

栄養状態

肥満度計算

肥満度+20%以上の者（肥満）

肥満度-20%以下の者（やせ）

→ 原因について十分検討する必要がある。

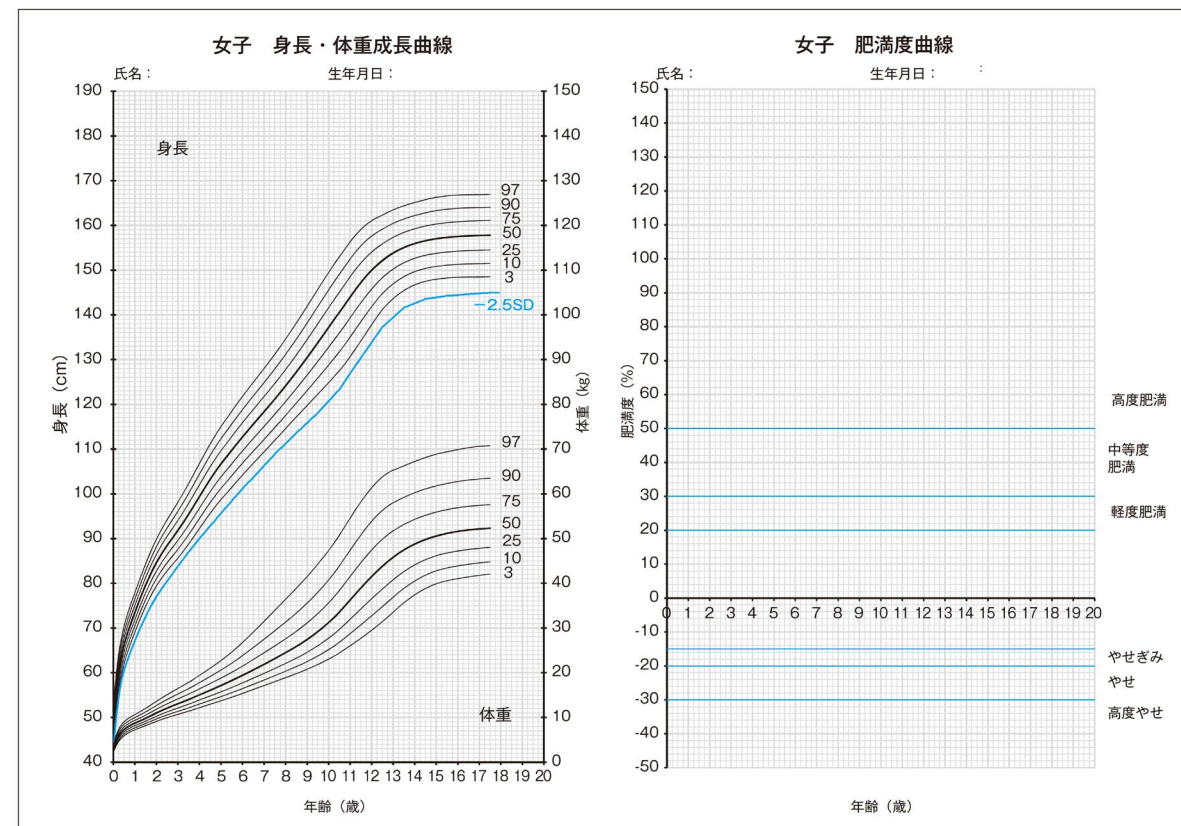
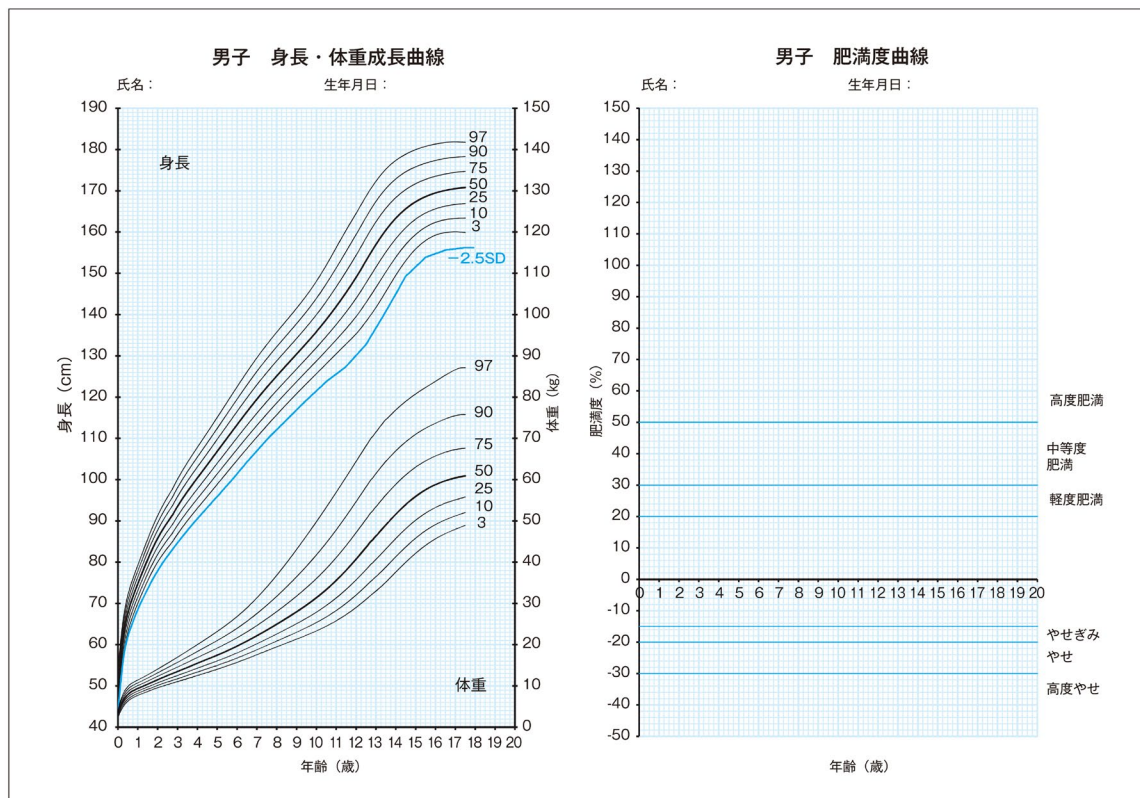
体重成長曲線と肥満度曲線

肥満度曲線が上向き（肥満）＋身長成長曲線が基準線に対して下向き（身長の伸びが正常を下回る）、

極端な低身長である肥満

疾患原因→医療機関への受診を勧める

成長曲線と肥満度曲線



<成長曲線、肥満度曲線について>

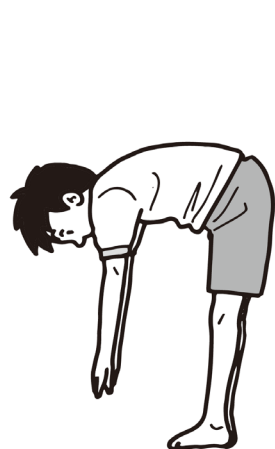
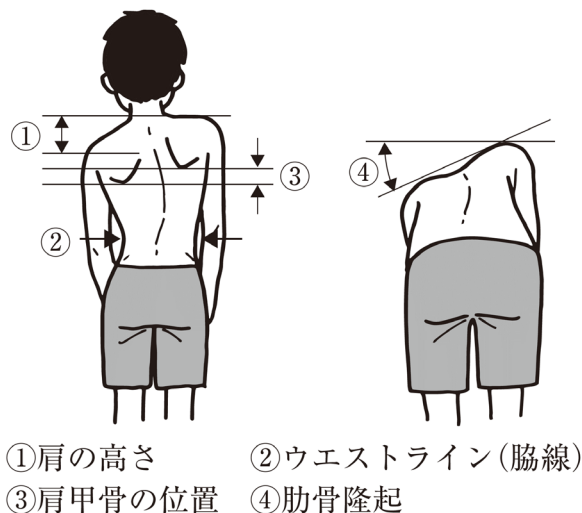
身長 of 最新値が97パーセンタイル以上	統計学的にみると異常に高いが、病気が原因であることはほとんどない。
過去の身長 of 最小値に比べて最新値が1 Zスコア以上大きい	思春期早発症などの病的状態が原因であると考えられる。
身長 of 最新値が3パーセンタイル以下	身長が統計学的にみると異常に低い、病気が原因であることはほとんどない。
過去の身長 of 最大値に比べて最新値が1 Zスコア以上小さい	甲状腺機能低下症などの病的状態が原因であると考えられる。
身長 of 最新値が-2.5 Zスコア以下	身長が極端に低いもので、病気が原因である可能性が高い。
肥満度の最新値が20%以上	必ずしも単純性肥満とは限らず、身長の伸びが異常に小さい場合は病的（症候性）肥満と考えて対応する必要がある。
過去の肥満度の最小値に比べて最新値が20%以上大きい	進行性の肥満。
肥満度の最新値が-20%以下	やせ。
過去の肥満度の最大値に比べて最新値が20%以上小さい	進行性のやせ。

*パーセンタイル：日本語では百分位といって、集団全体を百に均等に分けて身長や体重がその何番目に当たるかを示したもの

*Zスコア： $(\text{実測身長} - \text{平均身長}) \div \text{標準偏差}$

就学前健診及び定期健康診断

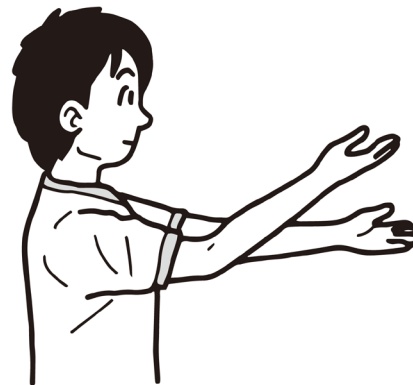
脊柱・胸郭・四肢の状態 視診および質問票調査



屈曲時の痛み



伸展時の痛み



両腕を伸ばすと、片方だけまっすぐ伸びない。



立ちすると、ふらつくともにチェック)。



ふらつく。後ろに転ぶ。しゃがむと痛みがある。

就学前健診及び定期健康診断

1. 視力

視力C（0.6～0.3）・D（0.3未満）の者は、全て眼科への受診を勧め、その指示に従うよう指導する。

2. 聴力

オーディオメーターで実施。

応答がなければ、難聴の疑い

表3 視力測定の実示・区分

視力測定の実示	A	B	C	D
区分	1.0以上	0.9～0.7	0.6～0.3	0.3未満

表4 視力判定の手順

視力の判定	使用視標	判定の可否	判定結果	次の手順	備考(事後措置等)
	0.3	判別できない	D	終了	視力C、Dの場合は眼科への受診を勧める。
		正しく判別	—	0.7で検査	
	0.7	判別できない	C	終了	視力Bの場合、幼稚園の年中、年少児を除く児童生徒等には受診を勧める。年中、年少児には受診の勧めは不要。
		正しく判別	—	1.0で検査	
	1.0	判別できない	B	終了	受診の勧めは不要。
		正しく判別	A	終了	

※ 「正しく判別」とは、上下左右4方向のうち3方向以上を正答した場合をいう。

※ 「判別できない」とは、上下左右4方向のうち2方向以下しか正答できない場合をいう。

就学前健診及び定期健康診断

眼科健診

感染性眼疾患に注意し、また、その他の眼瞼、睫毛、結膜、角膜など外眼部の疾病・異常の有無及び眼位の異常の有無を検査

感染性結膜炎、アレルギー性結膜炎、眼瞼炎

内反症、麦粒腫、霰粒腫

外斜位、外斜視、内斜視など

就学前健診及び定期健康診断

耳鼻科健診

対象疾患

耳 耳垢塞栓、滲出性中耳炎、慢性中耳炎

鼻 アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症、副鼻腔炎、慢性鼻炎

喉 アデノイドの疑い、扁桃肥大、扁桃炎、音声異常、言語異常

口腔 唇裂、口蓋裂およびその他の慢性疾患

その他 頭頸部領域の疾患

就学前健診及び定期健康診断

歯科検診

顎関節

歯列、咬合の状態

歯垢の付着

歯肉の状態

虫歯の有無

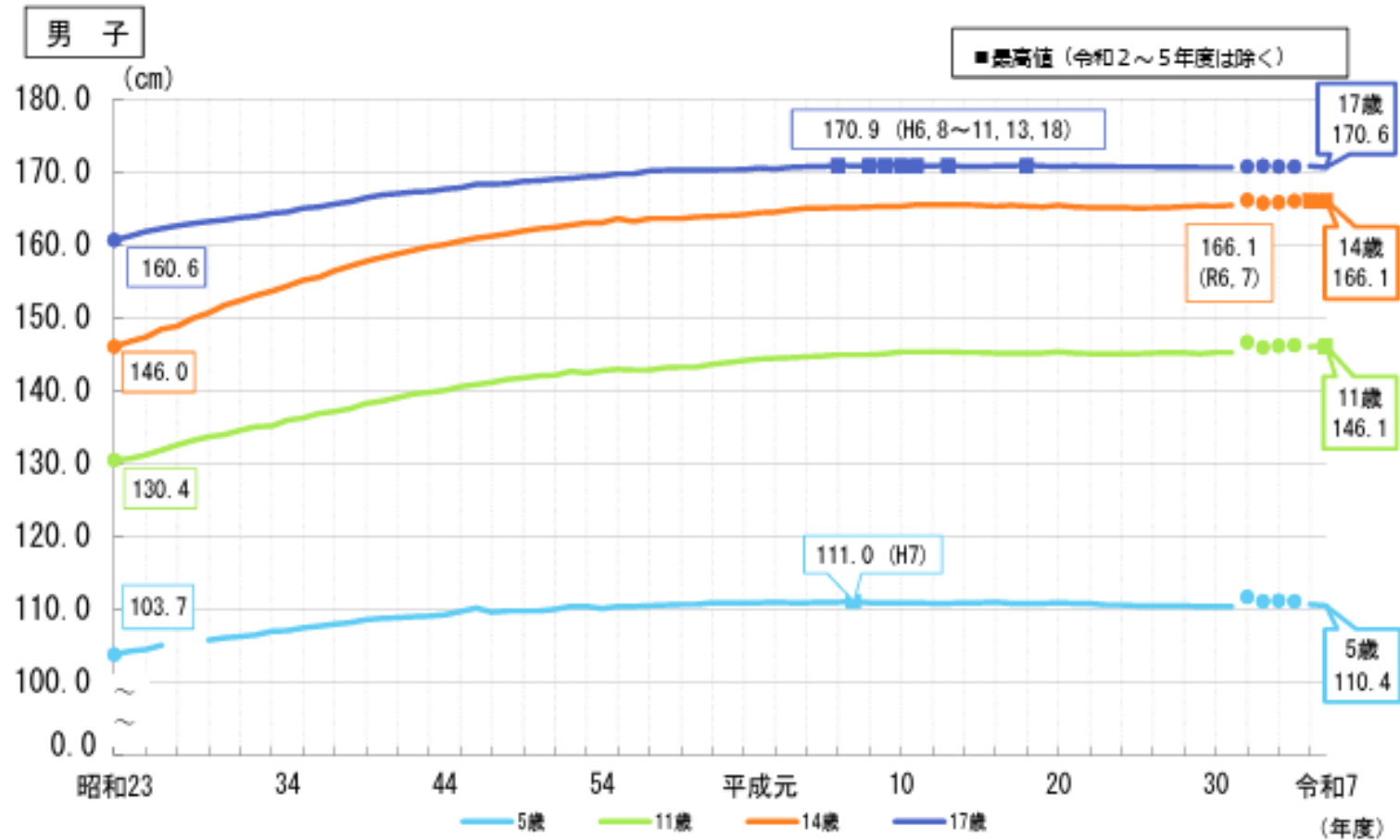
健康診断の実施項目②

- 職員健康診断

1. 身長、体重、腹囲
2. 視力・聴力
3. 結核
4. 血圧
5. 尿検査
6. 胃の疾病・異常の有無
7. 血液検査(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)
8. 心電図

身長：年齢別年次推移

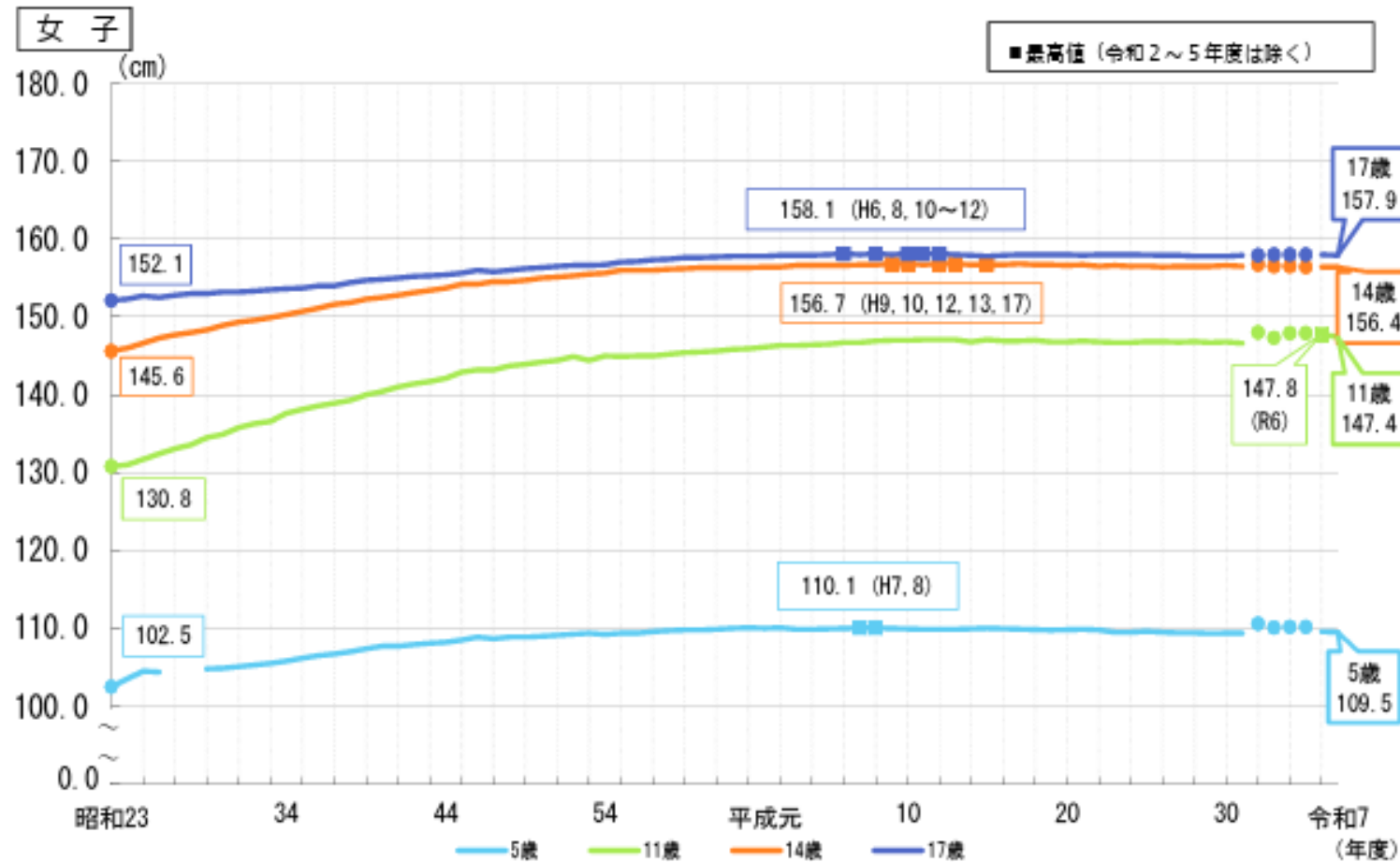
○身長の推移



(注) 5歳については、昭和27年度及び昭和28年度は、調査していない。4ページ、5ページの各図において同じ。

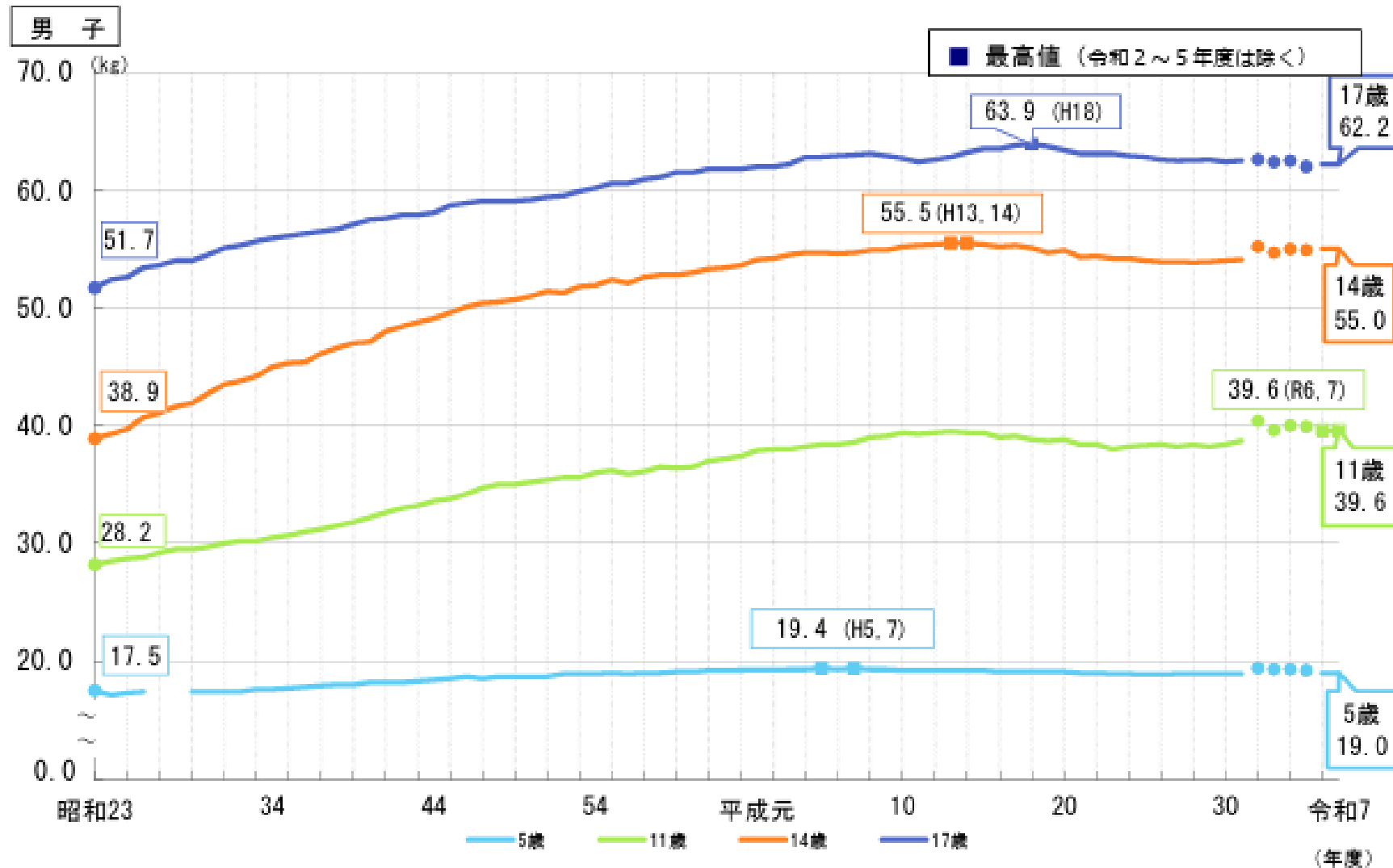
- 1994年あたりにピークを迎え、その後横ばい

身長：年齢別年次推移

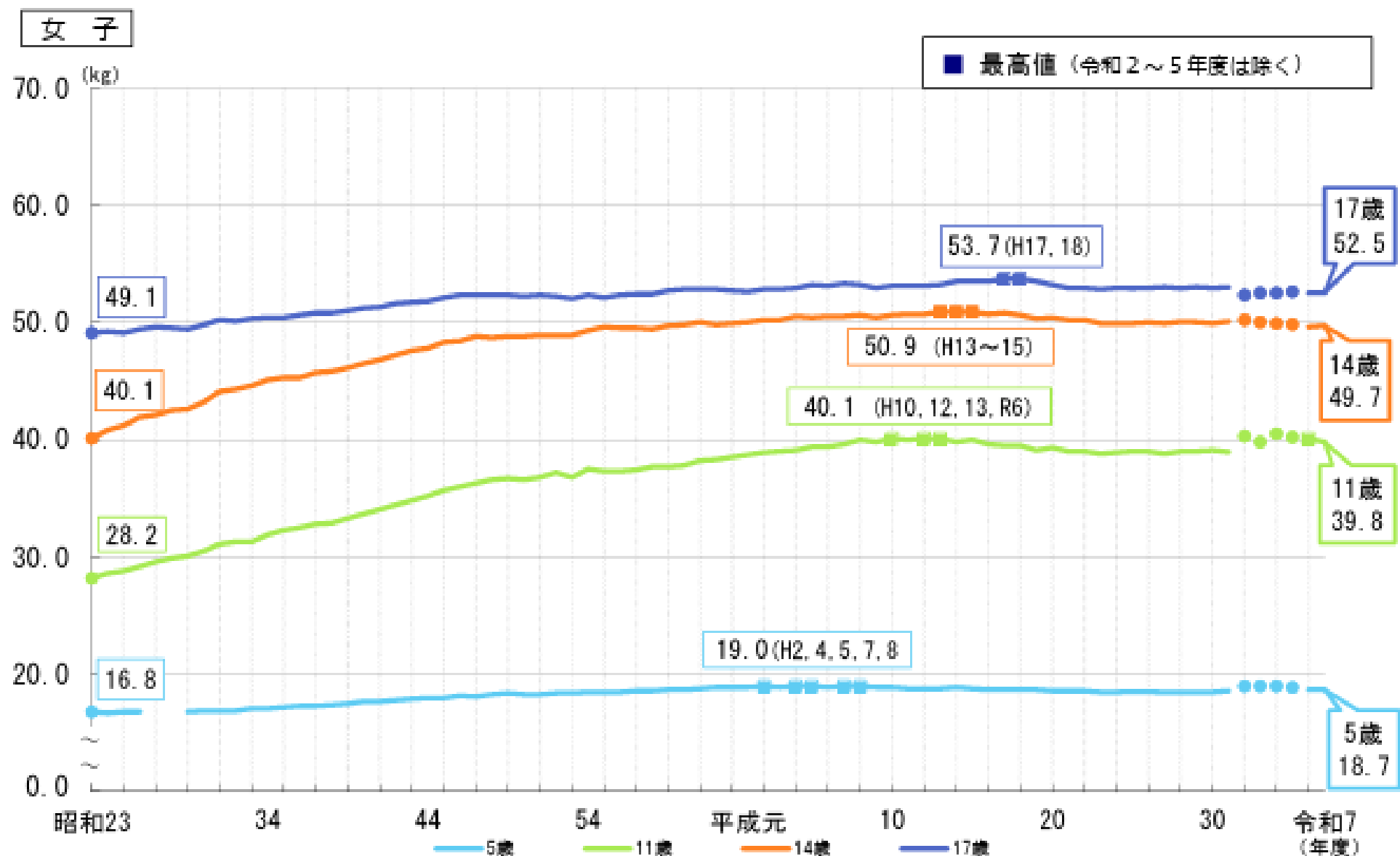


- 1994年あたりにピークを迎え、その後横ばい

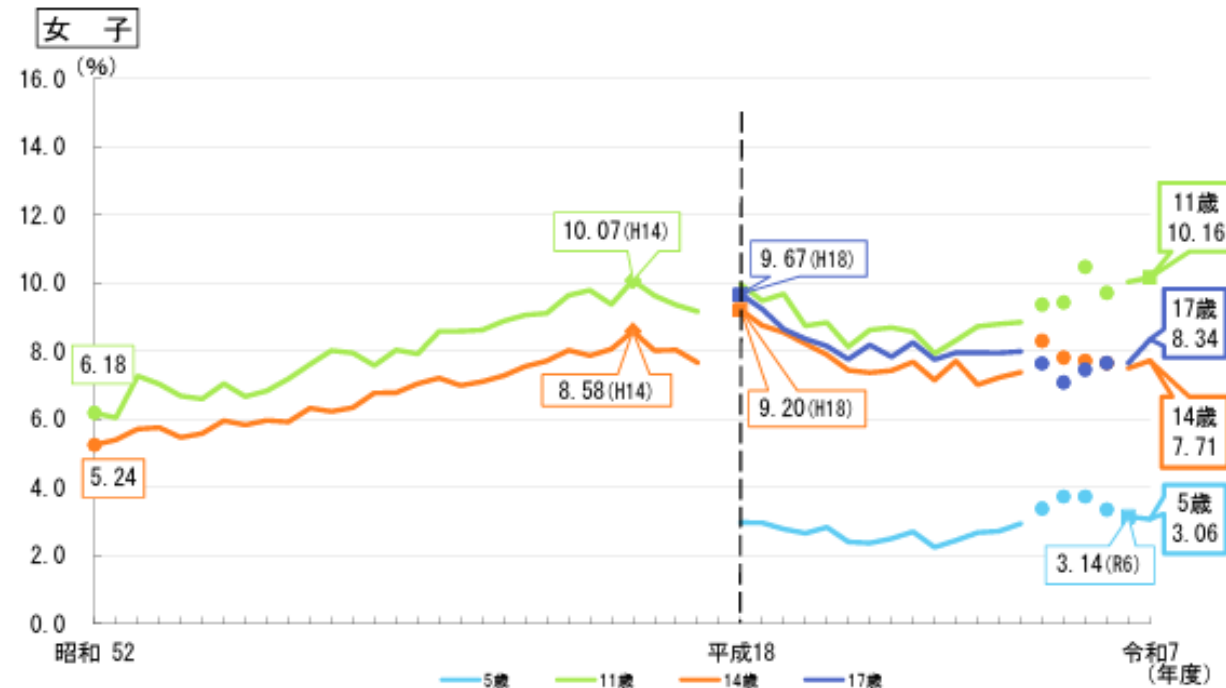
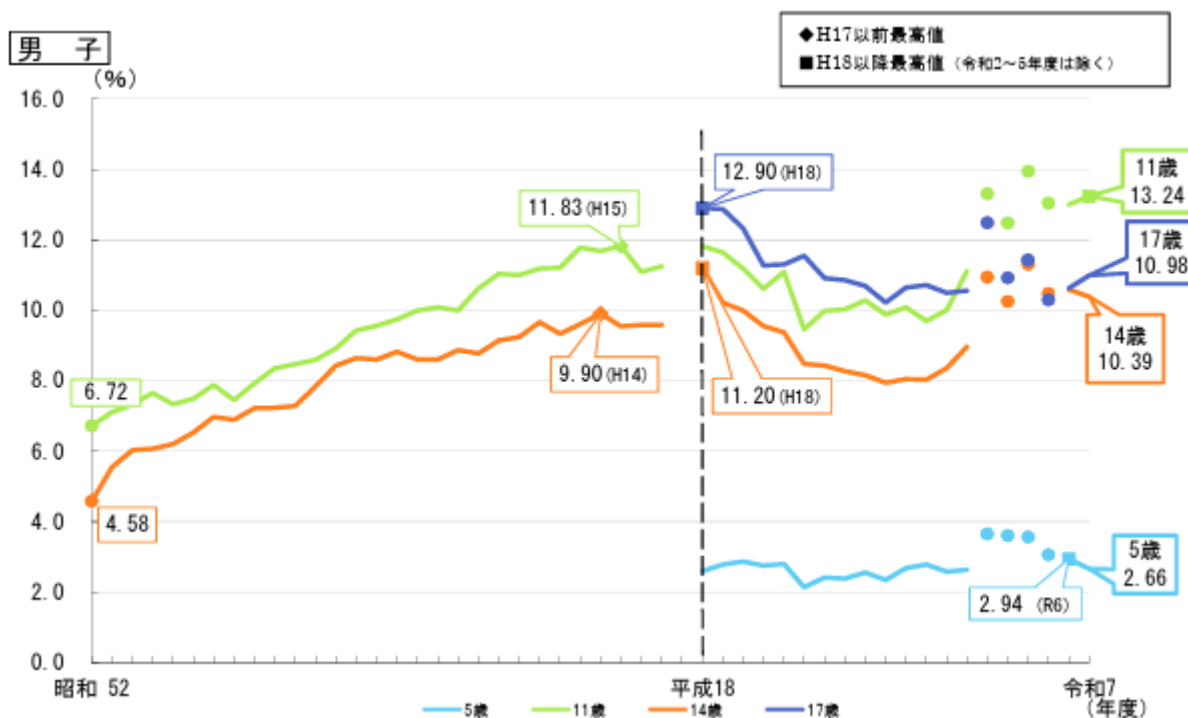
体重：年齢別年次推移



体重：年齢別年次推移

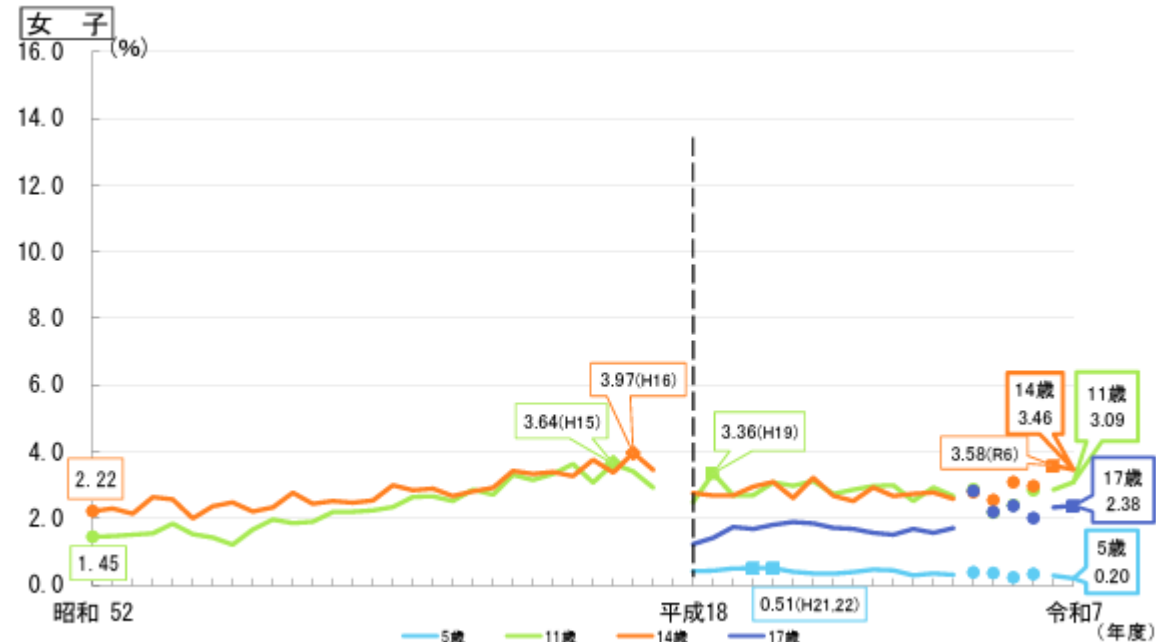
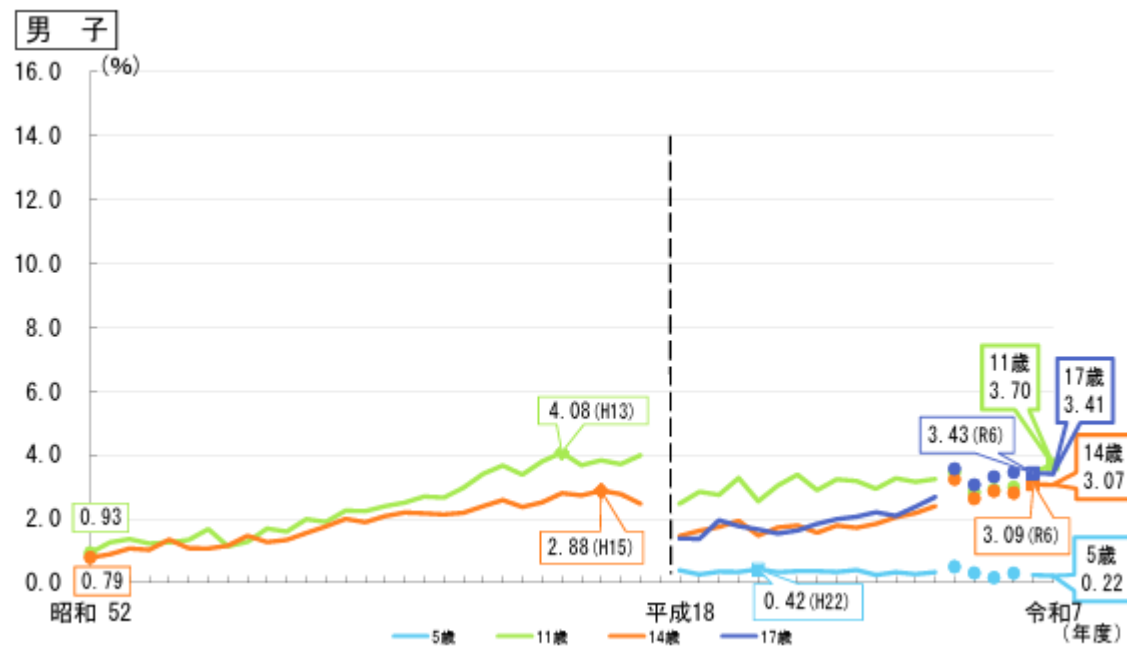


肥満傾向児の出現率の推移



- 肥満傾向児の割合は男女ともに小学校高学年が最も高く、特に男子は8歳以降1割を超えている。

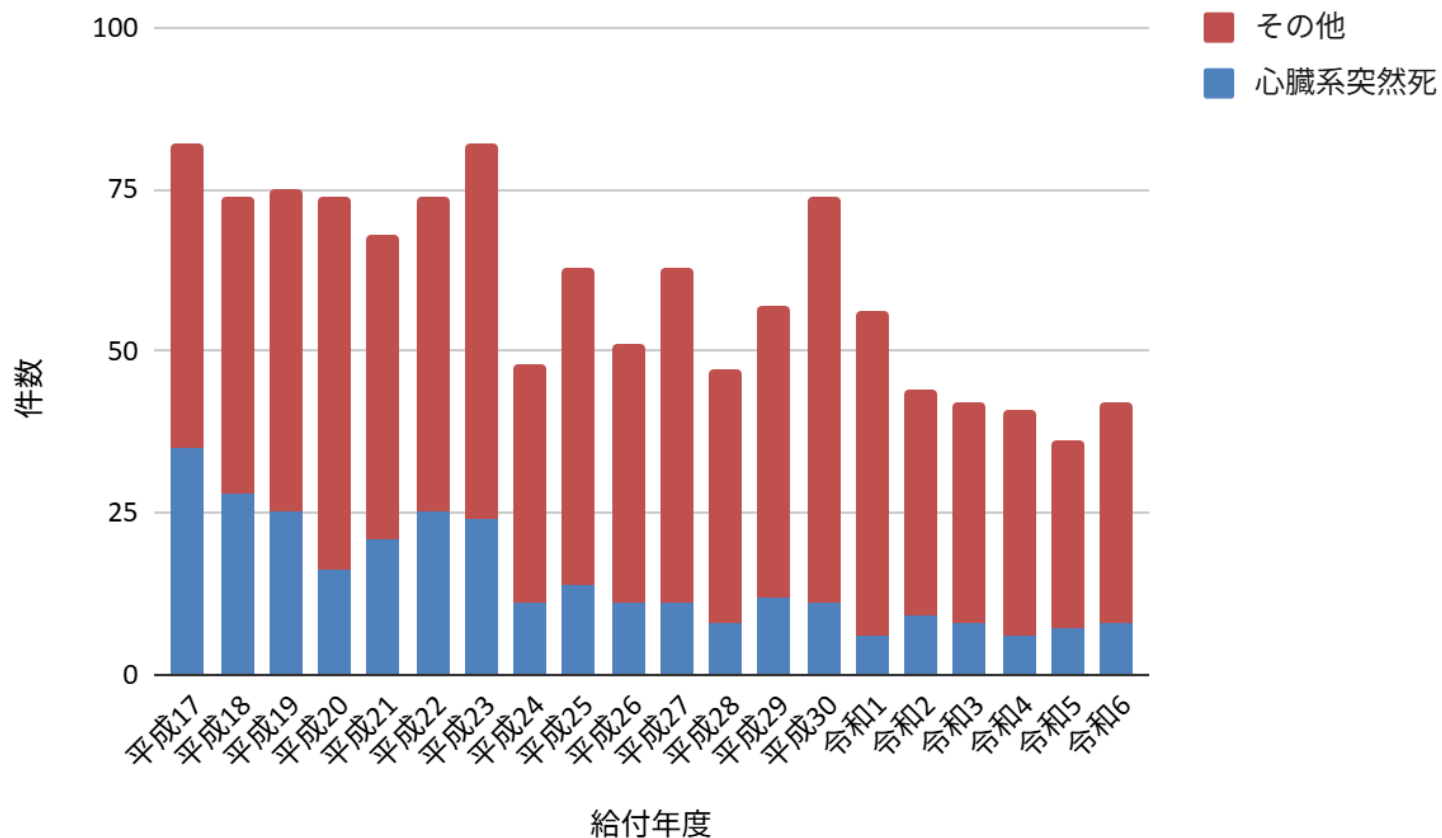
痩身傾向児の出現率の推移



- 痩身傾向児の割合は、男女とも10歳以降は約2%～3%台となっている。

心臓健診と突然死

給付年度別死因



- 突然死は全体として減少傾向
- 心臓系突然死も減少しつつあり、学校心臓検診とAEDの普及が児童生徒の突然死防止に貢献していると考えられる。
- 突然死の約40%を心臓系突然死が占めてたが、平成24 年度からその割合は減少傾向。

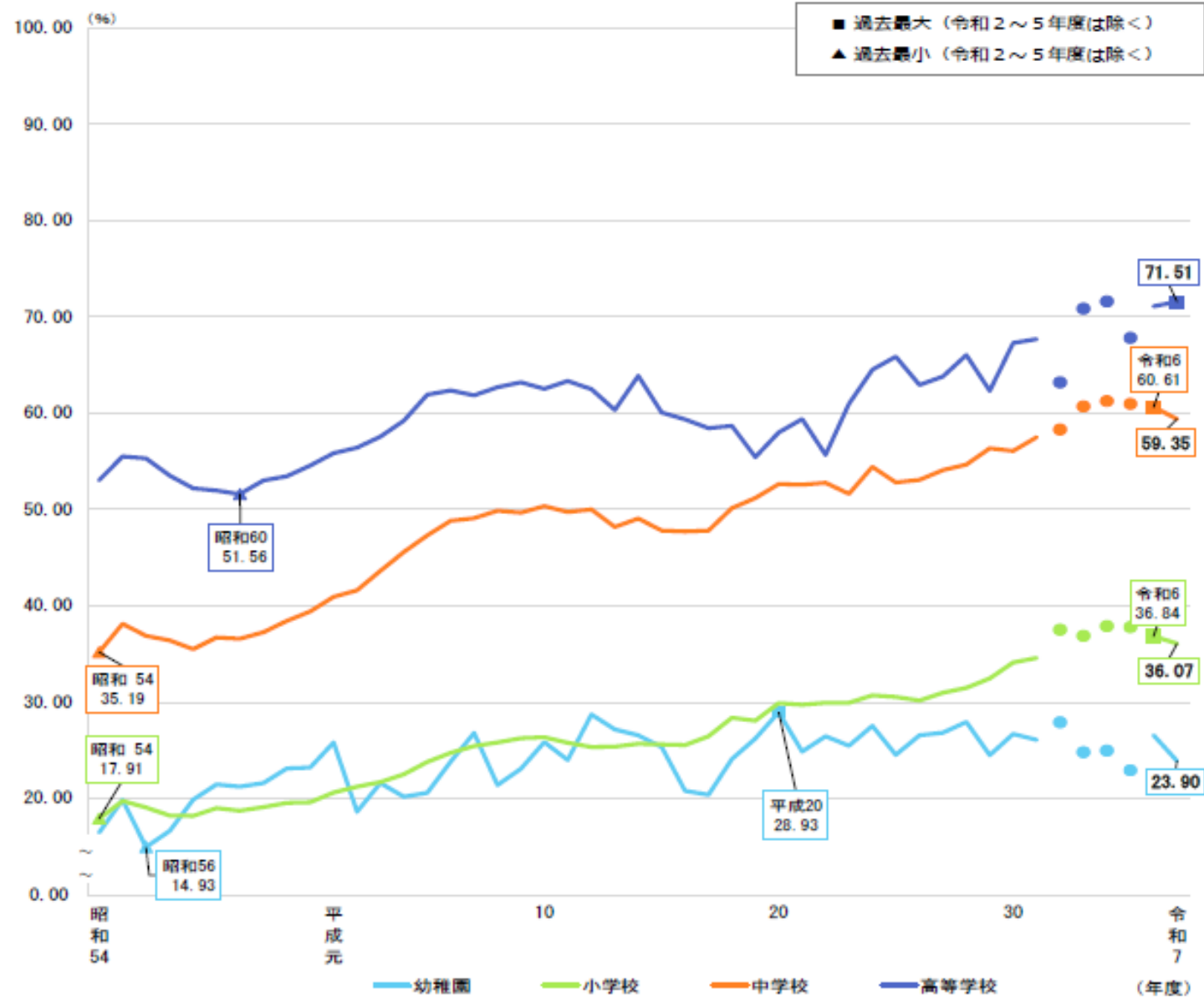
学校保健における疾患有病率

単位 (%)

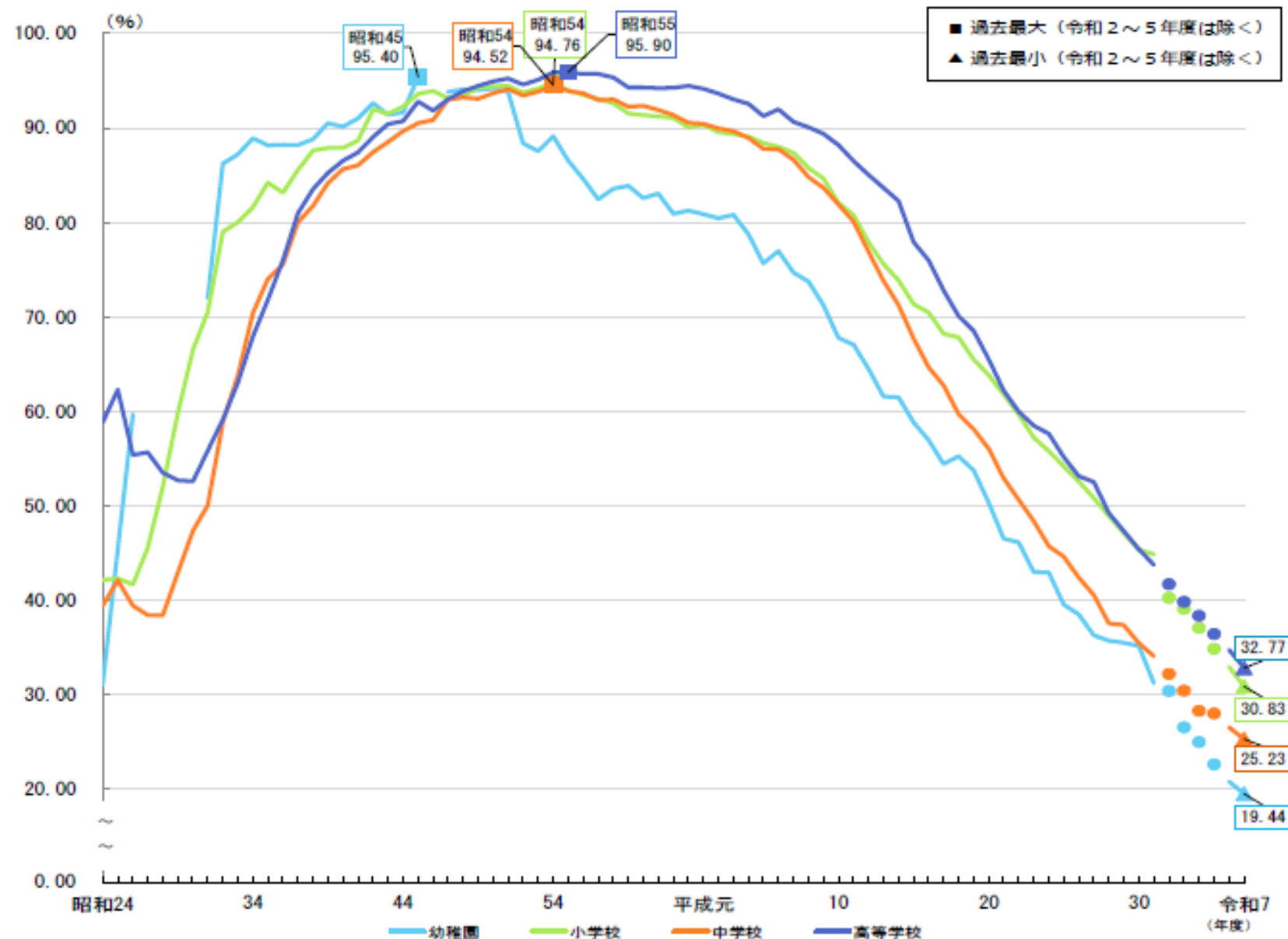
区分	裸眼視力 1.0未満の者	眼の 疾病・ 異常	耳疾患	鼻・副鼻 腔疾患	むし歯 (う歯)	アトピー 性皮膚炎	ぜん息	心電図 異常 (注)	蛋白検 出の者
幼稚園	23.90	1.75	2.41	2.61	19.44	1.62	1.30	...	0.59
小学校	36.07	5.79	6.20	11.36	30.83	3.29	3.22	2.52	0.95
中学校	59.35	5.24	4.32	10.87	25.23	3.00	2.14	3.40	2.69
高等学校	71.51	3.19	2.28	7.28	32.77	2.52	1.53	3.31	2.56

令和7年度学校保健統計結果より抜粋

○「裸眼視力1.0 未満の者」の割合



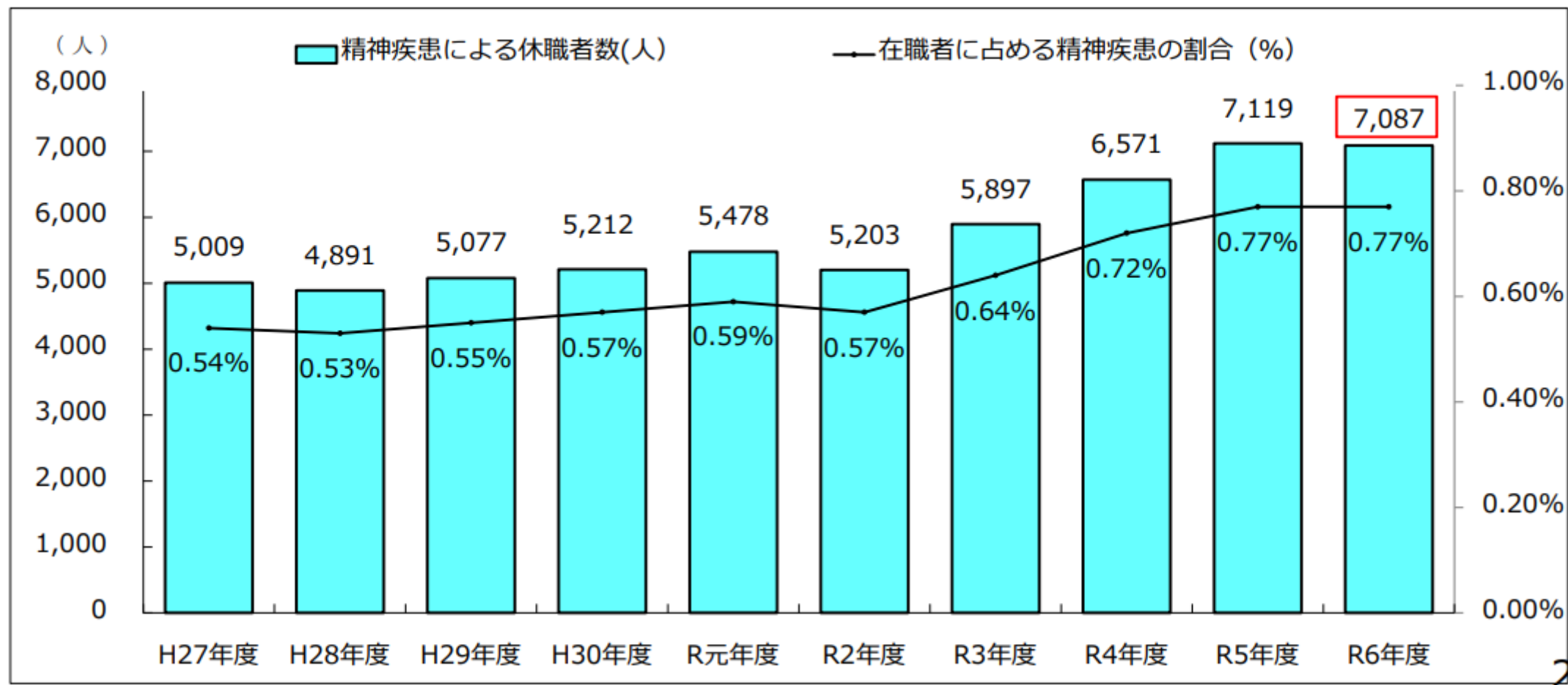
○むし歯（う歯）の者の割合



注：幼稚園については、昭和27～30年度及び昭和46年度は調査していない。

教職員の健康状態の現状

教育職員の精神疾患による病気休職者数の推移（平成27年度～令和6年度）



- 教育職員（※）の精神疾患による病気休職者数は、7,087人（全教育職員数の0.77%）
- 令和5年度（7,119人）から32人減少したものの、割合は横ばい。

こどものメンタルヘルス

原因

- ストレス
- 生活習慣の乱れ
- 児童虐待

結果

- 不登校
- 自殺

原因とも結果にもなりうるもの

- いじめ

子どものメンタルヘルス

- 大きな社会的なストレス → 子どものストレス反応
- ストレス反応
 - 心理的反応
 - 行動変化
 - 身体症状

ストレス反応

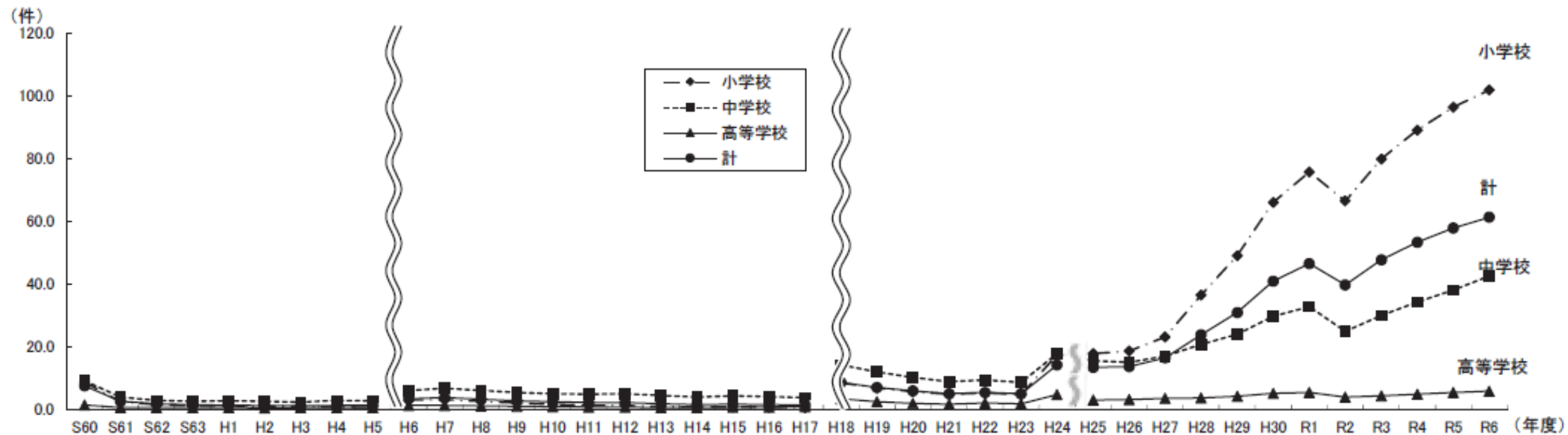
反応の種類	具体例
心理的反応	不安，イライラ，落ち込み，緊張，怒り，罪悪感，孤独感，疎外感，感情鈍麻，集中困難，思考力低下，判断/決断力低下 など
行動変化	かんしゃく，攻撃的行動，過激な行動，泣く，引きこもり，拒食や過食，チック，吃音，ストレス場面からの回避 など
身体症状	動機，頭痛，腹痛，疲労感，嘔吐，下痢，めまい，しびれ など

いじめ

H6.愛知県西尾市中学生
いじめ自殺事件

H.25.いじめ防止対策
推進法

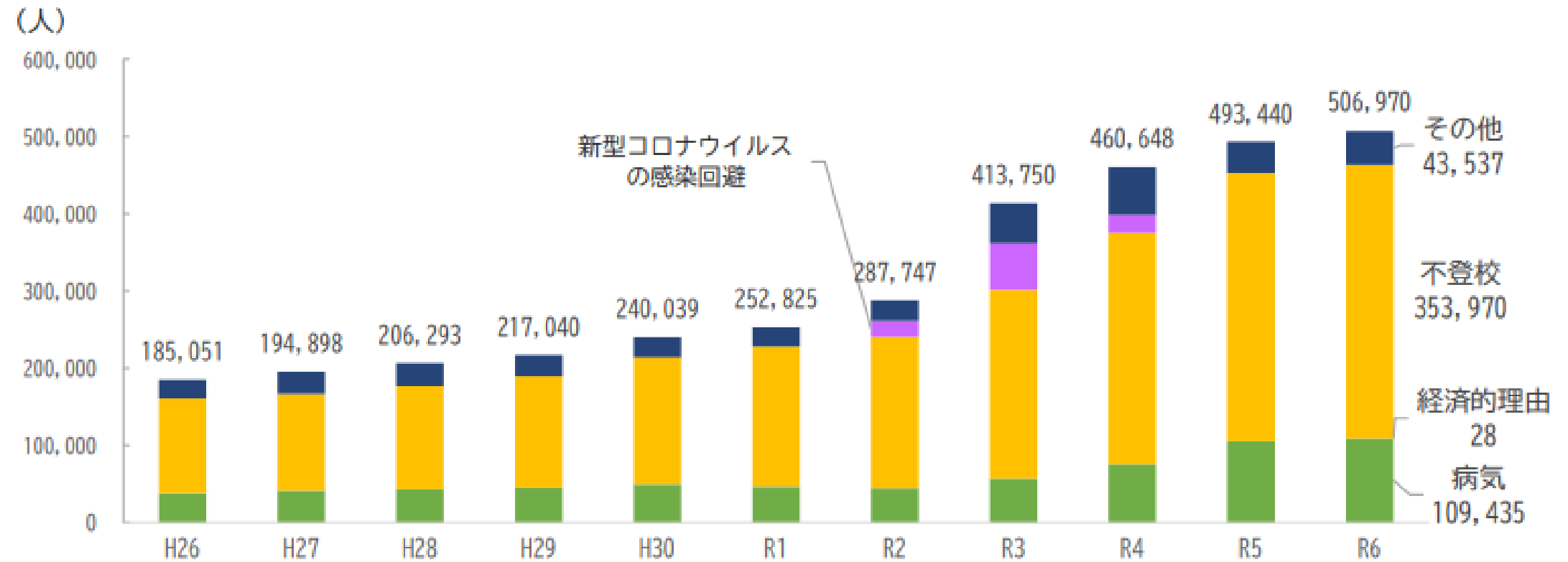
<参考3> いじめの認知(発生)率の推移(1,000人当たりの認知件数)グラフ



平成6年度よりいじめの定義から「学校としてその事実（関係児童生徒、いじめの内容等）を確認しているもの」という部分を削除したため、発生件数は急増した。
件数が増加しているのは認知件数が増加しているということであり、発生件数と認知件数はイコールではない。

不登校

小・中学校における長期欠席者数の推移



令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

学校における感染症への対応

- 学校において予防すべき感染症の考え方
診断

診察にあたった医師が身体症状及びその他の検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行われる。

学校から特定の検査等の実施を一律に求める必要はない。
(インフルエンザ迅速診断検査やノロウィルス検査など)

治癒の判断(治癒証明書など)も一律に求める必要はない

感染症の予防（学校保健安全法施行規則より）

（感染症の種類）

第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSCORONAウイルスであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。）

二 第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳せき、麻疹、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。）、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

出席停止について

- 第一種の感染症 一類感染症と結核以外の二類感染症 治癒するまで出席停止
- 第二種の感染症 各疾患によって規定される

学校保健安全法施行規則

学校保健法（昭和三十三年法律第五十六号）第十条、第十四条及び第十六条第五項並びに学校保健法施行令（昭和三十三年政令第百七十四号）第四条第一項、第五条第二項、第六条及び第九条第三項の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。

第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。一 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。

二 第二種の感染症（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。）にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

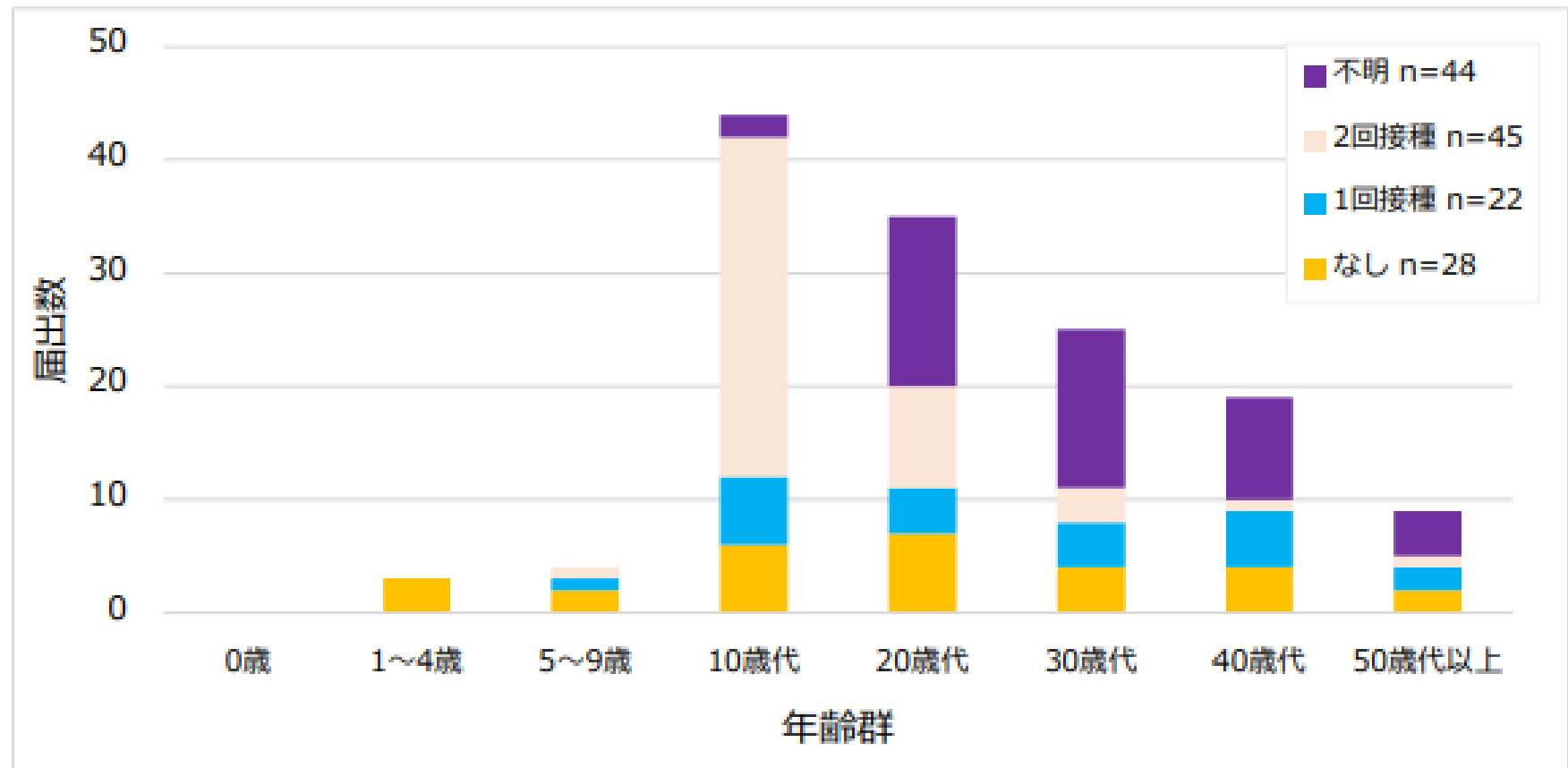
第2種の感染症①

病名	出席停止	侵入経路	潜伏期間	伝染可能期間	予防接種の有無	好発季節
インフルエンザ	発症後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで（幼児は解熱後3日を経過するまで）	飛沫	1～3日	発病後3～4日	有(任意)	冬 12～3月
百日咳	特有の咳が消失するまで または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで	飛沫	1～2週間	発病後28日	有(定期)	夏
麻疹(はしか)	解熱後3日を経過するまで	飛沫	10～12日	発疹の出る5日前～後4日	有(定期)	冬～春
流行性耳下腺炎(おたふく)	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで	飛沫	1～2週間	発病7日前から発病後9日	有(任意)	冬～春
風疹(3日ばしか)	発疹が消失するまで	飛沫	2～3週間	発疹のでる7日前から、でた後の7日間	有(定期)	春～夏

第2種の感染症②

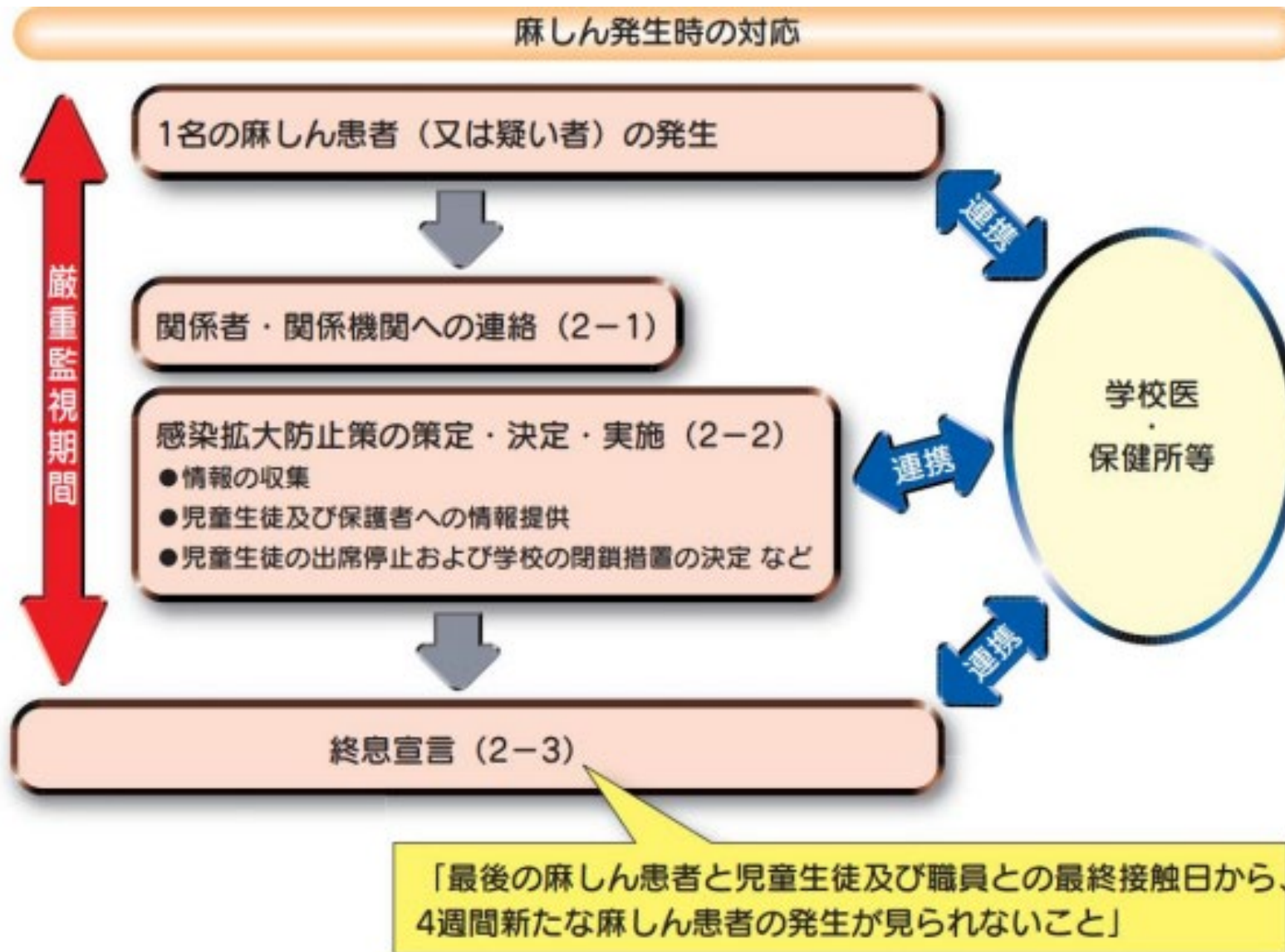
病名	出席停止	侵入経路	潜伏期間	伝染可能期間	予防接種の有無	好発季節
水痘 (水ぼうそう)	全ての発疹が痂皮化するまで	飛沫・直接	2～3週間	発疹のでる1日前からでた後の6～7日	有（定期）	冬～春
咽頭結膜熱 (プール熱)	主要症状が消失した後、2日を経過するまで	結膜接触・汚染物	5～7日	発病後2～3週	なし	夏～秋
結核	伝染のおそれが無くなるまで	飛沫	1～2ヶ月		有（定期）	なし
髄膜炎菌性髄膜炎	伝染のおそれが無くなるまで	飛沫	2～5日		有（任意）	なし

麻疹



出典：国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/020/2504_pertussis_RA.html

学校における麻疹対策ガイドライン



登校開始の数え方①（小学生インフルエンザの場合）

12 月						
月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3 発熱	4 発熱	5 発熱	6 発熱	7 解熱	8 解熱
9 解熱	10	11	12	13	14	15

登校開始の数え方①（小学生インフルエンザの場合）

12 月						
月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3 発熱 発熱後0日目	4 発熱 発熱後1日目	5 発熱 発熱後2日目	6 発熱 発熱後3日目	7 解熱 解熱後0日目 発熱後4日目	8 解熱 解熱後1日目 発熱後5日目
9 解熱 解熱後2日目 発熱後6日目	10 登校可能	11	12	13	14	15

登校開始の数え方②（小学生インフルエンザの場合）

12 月						
月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3 発熱	4 解熱	5 解熱	6 解熱	7 解熱	8 解熱
9	10	11	12	13	14	15

登校開始の数え方②（小学生インフルエンザの場合）

12 月						
月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3 発熱 発熱後0日目	4 解熱 解熱後0日目 発熱後1日目	5 解熱 解熱後1日目 発熱後2日目	6 解熱 解熱後2日目 発熱後3日目	7 解熱 解熱後3日目 発熱後4日目	8 解熱 解熱後4日目 発熱後5日目
9 登校可能	10	11	12	13	14	15